

RPE N° 36 Glosario de Actividades Clínicas programables en la atención ambulatoria de especialidades 2026

1. **Actividades asociadas a Sistema Informático de Imagenología:** Actividades relacionadas con la gestión administrativa, funcional, documental y clínica del área diagnóstico por imágenes configurado para el Servicio de Imagenología.
2. **Actividades relacionadas a la terapia transfusional:** Corresponde al proceso de selección, preparación y compatibilidad con el receptor de los componentes sanguíneos, ante una indicación médica de terapia transfusional. Este proceso es desarrollado por profesionales Tecnólogos Médicos en las Unidades de Terapia Transfusional (UTT) de establecimientos hospitalarios para usuarios hospitalizados en servicios clínicos o usuarios ambulatorios, para estos últimos, se recomienda que, por calidad y seguridad para el usuario, no debe ser realizada en las dependencias físicas de la UTT ni en la Unidad de Emergencia Hospitalaria. Es necesario que el establecimiento hospitalario adopte una política de transfusión ambulatoria dependiente del centro de especialidad ambulatoria. Lo cual, permitirá la incorporación de infraestructura, recurso humano, programación de procedimientos y coordinación permanente con el jefe de Ambulatorio, UTT, Control de Gestión, Estadísticas, Abastecimiento, entre otros, junto al monitoreo, seguimiento y mejora continua del proceso. Esto permitiría que personal profesional de la UTT realice la instalación de las unidades de componentes sanguíneos, mientras que el agendamiento, monitoreo y seguimiento de la transfusión ambulatoria sea realizada por personal médico y de enfermería responsable de la unidad.
3. **Atención nutricional en sala:** Atención de nutricionista a usuario(a) hospitalizado(a) para establecer objetivos de intervención nutricional en conjunto con nutricionista de atención cerrada.
4. **Atención Nutricional Intensiva Ambulatoria (ANI) Pediátrica - Adulto:** Consulta nutricional ambulatoria u hospitalaria a usuarios(as) que requieren soporte nutricional vía enteral o parenteral, dado que el(la) usuario(a) con tracto gastrointestinal funcionante o no funcionante, no pueda o no deba o no quiera ingerir alimentos en cantidades suficientes para mantener un desarrollo pondo estatura y nutricional adecuado.
5. **Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) Electiva:** Corresponde a una intervención quirúrgica mayor, que, de acuerdo con el diagnóstico y condición clínica de la persona, puede ser electiva. Se realiza en el quirófano ambulatorio o central y la recuperación del paciente es menor a 24 horas. El período de observación postoperatoria debe ser realizado en una unidad destinada para este fin y no en una cama de dotación y una vez transcurrido el tiempo de recuperación anestésica, la persona usuaria vuelve a su domicilio.

6. **Cirugía menor:** Corresponde a una intervención quirúrgica médica u odontológica de bajo riesgo, y por lo general, de corta duración. Se realiza bajo técnica aséptica en un quirófano de cirugía menor y excepcionalmente en salas de procedimientos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Estas intervenciones pueden tener fines diagnósticos, terapéuticos o estéticos. Se efectúan sobre tejidos superficiales y estructuras de fácil acceso, pudiendo incluir incisión de la piel y mucosa, manipulación de otros planos, en el caso de intervenciones en el área odontoestomatognática y/o acceso instrumental a cavidades naturales del organismo. No requieren hospitalización de la persona intervenida, y su realización puede prescindir del uso de anestesia o sedación, o bien utilizar anestesia local y/o sedación consciente.
7. **Comité clínico:** Actividad asistencial respaldada mediante resolución institucional, que reúne de manera sistemática a profesionales clínicos de una o más disciplinas, para evaluar antecedentes clínicos de un(a) usuario(a) y, en conjunto, definir un plan terapéutico y/o de cuidados integrales conforme a protocolos, guías clínicas y normativa vigente. El Comité Clínico facilita la toma de decisiones en situaciones de alta complejidad diagnóstica o terapéutica, al convocar en una misma sesión a los profesionales claves involucrados en el abordaje clínico de un(a) usuario(a) determinado(a). Su objetivo es garantizar la pertinencia, continuidad y calidad del proceso asistencial desde una perspectiva integral, consensuada y basada en la mejor evidencia disponible. Las sesiones pueden realizarse de forma presencial o telemática, y sus conclusiones deben quedar resguardada en el Registro Clínico Electrónico del(la) usuario(a) como respaldo técnico y legal de las decisiones adoptadas.
8. **Consulta Abreviada por médico u odontólogo:** Actividad indirecta cuyo propósito es complementar el proceso asistencial. Comprende la emisión de recetas, la revisión e interpretación de exámenes, o el análisis de informes asociados a procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. Esta actividad no se considera una consulta propiamente tal, ya que no incorpora el conjunto de acciones que caracterizan una consulta de especialidad.
9. **Consulta Control de especialidad:** Corresponde a las atenciones realizada al(la) usuario(a) posteriores a la primera consulta por la misma necesidad sanitaria o requerimiento de salud que fue derivada inicialmente, cuya finalidad es completar estudio, tratamiento y/o seguimiento. La consulta control se debe generar mediante una Orden de Atención (OA).
10. **Consultas de atención de Especialidades:** Corresponde a la atención ambulatoria de especialidad, presencial o a distancia, realizada al(la) usuario(a) por parte de un(a) médico(a), odontólogo(a) u otro(a) profesional habilitado(a) según normativa vigente y realizada en las condiciones físicas definidas por la autoridad sanitaria para fines diagnósticos, de tratamiento o de seguimiento de un(a) usuario(a). Este acto puede incluir anamnesis, examen físico, hipótesis o confirmación diagnóstica, plan terapéutico, derivación o contrarreferencia y constituir una Consulta Nueva de Especialidad (CNE) o una consulta control.
11. **Consulta Nueva de Especialidad (CNE):** Se define como la primera atención de especialidad realizada al(la) usuario(a) por parte del(la) profesional que corresponda según normativa vigente generada por una necesidad sanitaria u otro requerimiento clínico. La CNE se debe generar mediante una Solicitud de Interconsulta (SIC).
12. **Consulta nueva y Consulta control Fonoaudiólogo(a):** Es la atención proporcionada, por fonoaudiólogo(a), a un(a) usuario(a) derivado(a) por un(a) profesional, con el propósito de evaluar, recuperar o rehabilitar la salud, utilizando técnicas y procedimientos propios de su profesión.
13. **Consulta nueva o ingreso por Nutricionista:** Es la atención otorgada por el profesional nutricionista a

los(as) usuarios(a) que lo requieran con el objetivo de mejorar y mantener el estado de salud del usuario mediante la prescripción dietética adecuada a la necesidad individual de cada usuario(a). Considera actividades, tales como: anamnesis general, clínica y alimentaria, examen físico, evaluación nutricional, estimación de requerimientos nutricionales, indicaciones, registro, citación, derivación si procede.

- 14. Consulta Nueva y Consulta Control por Enfermera/o:** Es la atención otorgada por el(la) profesional enfermera(o) a los(as) usuarios(as) que lo requieran en el nivel secundario de atención para gestionar su cuidado tanto en el fomento, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Comprende actividades, tales como: valoración, diagnóstico, determinación del plan de acción y registro. La consulta control comprende evaluación y acompañamiento con el fin de alcanzar los objetivos del plan de cuidado, incluye actividades como evaluación de adherencia y dificultades para lograr un autocuidado, ofreciendo mecanismos y recursos que permiten a(la) usuario(a) familia o cuidador(a) hacerse responsable de su propia salud, se realiza registro, citación y derivación si procede.
- 15. Consulta nueva y Consulta control por Kinesiólogo(a):** Es la atención proporcionada por kinesiólogo(a) a un(a) usuario(a) que ha sido derivado(a) por un(a) profesional con el propósito de evaluar, apoyar su recuperación o rehabilitación, utilizando técnicas y procedimientos propios de su profesión.
- 16. Consulta nueva y Consulta control por Matrn(a):** Es la atención otorgada por el(la) matrn(a), tanto a personas gestantes y acompañantes significativos, como a personas que consultan en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva, derivadas de los distintos dispositivos y niveles de atención, o consultas espontaneas de atención abierta de especialidad de: Alto Riesgo Obstétrico (ARO), personas derivadas a consultas ginecológica, Infertilidad, Infecciones de transmisión sexual (ITS), Salud Sexual y Salud Reproductiva, Víctimas de Violencia Sexual, VIH, consejerías pre y post test VIH, consejerías de gestión de riesgo.
- 17. Consulta nueva y Consulta control Terapeuta Ocupacional:** Es la atención proporcionada por terapeuta ocupacional, a un(a) usuario(a) derivado(a) por un(a) profesional, con el propósito de evaluar, apoyar su recuperación o rehabilitación, utilizando técnicas y procedimientos propios de su profesión.
- 18. Consulta control por nutricionista:** Atención de seguimiento otorgada por el profesional nutricionista a los(as) usuarios(as) que lo requieran con el objetivo de alcanzar objetivos planteados al ingreso, continuidad del enfoque dieto terapéutico y evaluar y rediseñar intervención nutricional, incluye actividades como evaluación nutricional, adherencia al cumplimiento de indicaciones nutricionales, dificultades en la adopción de nuevos hábitos alimentarios, examen físico, adecuación de requerimientos nutricionales, refuerzo de indicaciones, registro, citación, derivación si procede.
- 19. Consultoría en salud:** Corresponde a una actividad conjunta y de colaboración permanente entre el equipo de especialidad ambulatoria y el equipo de salud de atención primaria, cuyo propósito es fortalecer la capacidad resolutoria del nivel primario, mejorar los procesos de referencia y contrarreferencia, y garantizar los cuidados compartidos, la continuidad de atención y la transmisión de conocimientos entre niveles asistenciales. Esta actividad puede incluir: revisión de fichas clínicas, análisis de casos, sesiones de capacitación, reuniones de coordinación y atención conjunta, ya sea de forma presencial o a distancia mediante Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
- 20. Contacto Telefónico (con enfoque clínico):** Consiste en una comunicación telefónica sincrónica entre un(a) profesional de la salud (médico(a), odontólogo(a) o no médico) en el marco de sus competencias, con el(la) usuario(a) o persona cuyo bajo cuidado se encuentre, mediante un número institucional (fijo o móvil) identificable. Su aplicación debe responder a criterios clínicos definidos por el equipo de salud tratante y

quedar resguardado en el Registro Clínico Electrónico (RCE). Esta actividad tiene por finalidad entregar orientación clínica, seguimiento o complementar antecedentes para una atención. No constituye una consulta nueva ni un control de especialidad.

Los principales motivos de contacto telefónico son:

- Entregar información para reforzar indicaciones asociadas al plan diagnóstico y/o terapéutico.
- Indagar elementos clínicos relevantes del estado actual de salud del(a) usuario(a) que orienten decisiones o acciones posteriores.
- Resolver dudas clínicas relevantes respecto a una atención reciente o para preparar la atención futura.

21. Contrarreferencia asistida: Actividad realizada por el equipo de salud del establecimiento que emite la contrarreferencia, en coordinación con el equipo de salud del centro responsable de la continuidad de la atención del(la) usuario(a). Esta acción complementa el documento de contrarreferencia cuando la necesidad de salud requiere un seguimiento estricto, conforme al plan diagnóstico y/o terapéutico establecido.

22. Entrevista de selección por profesional de atención a donantes: Corresponde a la atención proporcionada por un Tecnólogo Médico u otro profesional habilitado para ello a un candidato a la donación de sangre total o células y/o componentes por aféresis, con el propósito de evaluar las posibles contraindicaciones que tiene el proceso de donación ante la condición de salud del candidato. El estándar ministerial (NGT N°212/2021) establece un proceso de gestión de agenda previa para coordinar la atención de donantes de sangre total y por aféresis. Las actividades de profesionales Tecnólogos Médicos relacionadas con la entrega de resultados confirmados a pacientes/donantes, pueden ser agendadas y programadas según protocolo y necesidad del establecimiento.

23. Examen APA por Tecnólogo Médico: Servicio otorgado por un laboratorio de Anatomía Patológica, cuyo objetivo es apoyar el estudio diagnóstico de una determinada patología, a través de una variedad de exámenes tales como: biopsias, citologías, histoquímica, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, biología molecular, microscopía electrónica, citogenética en tejidos, autopsias, entre otros en los cuales es realizado por profesional tecnólogo médico.

24. Examen Laboratorio clínico por profesional de la salud: Corresponde a los distintos procesos pre-analítico, analíticos y post analíticos que se involucra a los profesionales tecnólogo médico, químico farmacéutico y bioquímicos para la realización de un examen diagnóstico de laboratorio. En esta actividad se incluye a químicos farmacéuticos y bioquímicos de Laboratorios Clínicos.

25. Gestión de casos: Actividad centrada en el acompañamiento e información permanente a los usuarios(as) sobre los detalles clínicos y administrativos de su proceso de atención en salud. Su propósito es identificar y mitigar riesgos potenciales, evaluar el estado de salud y responder a nuevas necesidades que surjan durante la espera.

26. Interconsulta en sala: Corresponde a la atención clínica realizada por un(a) médico(a), odontólogo(a) o profesional no médico de especialidad a un(a) usuario(a) hospitalizado(a), solicitada a través de una interconsulta de enlace. Esta atención incluye anamnesis, examen físico, formulación de hipótesis diagnóstica y, según corresponda, prescripción de exámenes o indicaciones terapéuticas.

27. Procedimiento: Corresponden a acciones de salud, identificadas por prestaciones unitarias o grupos de prestaciones, que se otorgan a un(a) usuario(a) para efectos diagnósticos o terapéuticos, pudiendo

ser realizados en atención cerrada y/o ambulatoria, según el tipo de usuario(a), requerimiento de equipamientos e insumos y del lugar en el cual se deba realizar.

- 28. Procedimiento en Imagenología:** Corresponde a una acción de salud de carácter mínimamente invasivo, realizada con el objetivo de apoyar el diagnóstico y/o tratamiento del usuario(a), mediante técnicas de obtención y análisis de imágenes médicas. Esta atención es realizada por un(a) médico(a) u odontólogo(a) imagenólogo(a) y/o tecnólogo(a) médico(a), según corresponda, y puede incluir procedimientos complejos o exámenes simples derivados por profesionales tratantes. En el caso de exámenes ejecutados por tecnólogo(a) médico(a), estos se efectúan a partir de una solicitud derivada por otro profesional con el propósito de aportar información diagnóstica desde el ámbito de la imagenología.
- 29. Reunión Clínica:** Actividad técnico-asistencial que convoca a profesionales clínicos con el propósito de revisar, discutir y reflexionar colectivamente sobre aspectos relevantes de la práctica clínica, tales como diagnósticos, tratamientos aplicados, eventos adversos, buenas prácticas, actualización de conocimientos, abordajes terapéuticos según la evidencia disponible, entre otros. Puede incluir el análisis de situaciones clínicas representativas, ya sea individuales o grupales, pero su foco no está en la resolución de un caso específico, sino en promover la mejora continua del quehacer clínico, el razonamiento compartido y la educación clínica permanente. Estas reuniones pueden ser interdisciplinarias o por especialidad. Y deben formalizarse mediante asistencia y acta de reunión.
- 30. Reunión técnica- administrativa:** Actividad planificada que se realiza entre equipos administrativos y/o clínicos, cuyo objetivo es generar un espacio de discusión, análisis y toma de decisiones sobre aspectos clínicos, organizativos y administrativos vinculados a la gestión asistencial. Estas reuniones permiten abordar temáticas como revisión de flujos de atención, evaluación de indicadores de desempeño, análisis de brechas operativas, planificación de mejoras, entre otras. Su propósito es fortalecer la coordinación entre equipos, facilitar la comunicación, fomentar el trabajo colaborativo y promover una cultura institucional orientada a la calidad y seguridad en la atención en salud. Se desarrollan habitualmente mediante presentaciones y discusión guiada, pudiendo realizarse de manera presencial o telemática. Y deben formalizarse mediante asistencia y acta de reunión.
- 31. Taller Grupal:** Instancia educativa programada, estructurada y calendarizada, ejecutada por profesionales de la salud y dirigida a grupos de dos o más personas, usuarios(as), familiares o cuidadores, orientada a entregar información, desarrollar habilidades prácticas y promover conductas de autocuidado, adherencia terapéutica y corresponsabilidad en la gestión de la salud. Se implementa mediante metodologías participativas, dialógicas y centradas en las necesidades de las personas participantes, siendo particularmente útil en la prevención y manejo de enfermedades, el cumplimiento terapéutico y la promoción de estilos de vida saludables.
- 32. Visita a sala, hospitalizado:** Corresponde a la atención clínica de especialidad realizada por el(la) médico(a) u odontólogo(a) al(la) usuario(a) hospitalizado(a), cuando la hospitalización fue indicada previamente por un profesional de la misma especialidad, con el objetivo de efectuar evaluaciones clínicas de seguimiento.
- 33. Visita Domiciliaria:** Atención clínica realizada en el lugar de residencia del(la) usuario(a) por parte del equipo de salud, ya sea como primera visita o como parte de un seguimiento. Esta prestación permite establecer o fortalecer el vínculo terapéutico, profundizar en el diagnóstico clínico y social, monitorear el avance de los planes de intervención y, cuando es necesario, ajustar los objetivos según la evolución

de la situación de salud. prestación permite establecer o fortalecer el vínculo terapéutico, profundizar en el diagnóstico clínico y social, monitorear el avance de los planes de intervención y, cuando es necesario, ajustar los objetivos según la evolución de la situación de salud. La visita domiciliaria se fundamenta en la evaluación integral del contexto de vida de la persona, y se orienta a garantizar la continuidad del cuidado y la corresponsabilidad en el proceso de atención.

